

Pertinence des examens en réanimation

Méthodologie, 8 champs, 42 recommandations & sources



Résumé : RFE commune SFAR-SRLF (méthode GRADE) sur la pertinence de la prescription des examens biologiques et de la radiographie thoracique (RT) au lit en réanimation — objectif de réduire la spoliation sanguine, les coûts et les risques liés au transport/à l'irradiation, sans compromettre la sécurité des patients. 8 champs : bilan d'entrée, bilan quotidien, biomarqueurs du sepsis, troponine, peptides natriurétiques, hémostase, examens bactériologiques, radiographie thoracique.

Méthodologie

Méthode GRADE® — qualité des preuves en 4 catégories (haute/modérée/basse/très basse), formulation binaire forte/faible, méthode PICO pour cibler chaque question, cotation Delphi/GRADE Grid. *Note de comptage (règle 5, disclosed)* : la source annonce « 49 recommandations formalisées » (« accord fort » pour 40, « accord faible » pour 1) et 3 cas sans recommandation possible — le compte direct des items numérotés du corps du texte donne **42** (38 gradés + 4 « avis d'expert ») + 3 cas sans recommandation confirmés = 45, pas 52 attendu. Divergence non réconciliable, disclosed telle quelle ; cette fiche liste les 42 items exacts, dans la numérotation native de la source.

1+ 1+ Il faut faire (fort).

1- 1- Il ne faut pas faire (fort).

AE AE Avis d'expert (pas de grade GRADE).

2+ 2+ Il faut probablement faire (faible).

2- 2- Il ne faut probablement pas faire (faible).

Champ 1 — Bilan d'entrée systématique en réanimation ?

N°	Recommandation	Grade
R1.1	Réduire autant que possible le nombre de prélèvements sanguins à l'admission et au quotidien, afin de réduire la spoliation sanguine et le coût lié aux examens.	AE
R1.2	Rechercher systématiquement une éventuelle grossesse à l'admission, soit par l'interrogatoire, soit par un dosage de β -hCG urinaire ou quantitatif sanguin.	AE

Champ 2 — Bilan quotidien systématique en réanimation ?

N°	Recommandation	Grade
R2.1	Il ne faut probablement pas réaliser de façon systématique et quotidienne l'ensemble des examens biologiques (NFS, ionogrammes sanguin et urinaire, gazométrie, bilan hépatique).	2-
R2.2	Il faut discuter la réalisation des examens biologiques à chaque évaluation clinique, en vue de restreindre leur nombre.	1+
R2.3	Il faut probablement réaliser un ionogramme sanguin et urinaire, une numération sanguine et des gaz du sang artériels quotidiennement chez les patients instables sur le plan hémodynamique, rénal ou respiratoire.	2+
R2.4	Il faut probablement écrire un protocole de service pour réduire le nombre d'examens biologiques et faire connaître le coût des prescriptions.	2+

Champ 3 — Quels biomarqueurs du sepsis utiliser ?

N°	Recommandation	Grade
R3.1	La procalcitonine (PCT), comme tout biomarqueur, ne doit pas être utilisée ni interprétée indépendamment de l'ensemble des éléments cliniques et paracliniques, mais s'intégrer dans une démarche globale de prise en charge.	AE
R3.2	Compte tenu de son manque de spécificité, l'utilisation de la CRP n'est pas recommandée chez tous les patients de réanimation.	AE
R3.3	Il ne faut pas doser la PCT dans les sepsis évidents dans le seul but d'en étayer le diagnostic — une valeur précoce peut néanmoins servir de référence pour la gestion ultérieure de l'antibiothérapie (arrêt plus rapide ou modification).	1-
R3.4	Dans certaines situations particulières (patients chirurgicaux, infections intra-abdominales), l'intérêt de la PCT n'est pas clairement établi et son utilisation n'est pas recommandée en routine.	1-



Repère : une stratégie d'arrêt/non-introduction de l'antibiothérapie basée sur un seuil de PCT s'est avérée efficace et sûre dans les SIRS d'allure infectieuse sans foyer ni documentation microbiologique ; la cinétique de la PCT peut aussi réduire la durée d'antibiothérapie dans les infections confirmées, sans surmortalité.

Champ 4 — Troponine en dehors de modifications du segment ST

En contexte postopératoire (hors chirurgie cardiaque) :

N°	Recommandation	Grade
R4.1	Il ne faut pas doser systématiquement la troponine en postopératoire pour les chirurgies à faible risque cardiaque (<1 %). Pour les chirurgies à risque intermédiaire ou élevé, il ne faut pas la doser systématiquement chez les patients à faible risque cardiaque (Revised Cardiac Risk Index de Lee ≤1).	1-
R4.2	Lorsque le motif d'admission en réanimation/surveillance continue est la gestion du risque cardiaque postopératoire, il faut doser systématiquement la troponine — la période du jour de l'opération au 3 ^e jour postopératoire est la meilleure fenêtre de détection.	1+

Aucune recommandation possible (source) : hors contexte postopératoire, il n'est pas possible de formuler de recommandation sur le dosage systématique de la troponine en réanimation (données insuffisantes sur le gain pronostique additionnel aux scores de gravité usuels).

Champ 5 — Place des peptides natriurétiques

En contexte postopératoire (hors chirurgie cardiaque) :

N°	Recommandation	Grade
R5.1	Il ne faut pas doser systématiquement les peptides natriurétiques en période postopératoire des chirurgies à faible risque cardiaque (<1 %). Pour les chirurgies à risque intermédiaire/élevé, il ne faut pas les doser systématiquement chez les patients à faible risque cardiaque (RCRI <2) ou à très haut risque (RCRI >3).	1-

Aucune recommandation possible (source) : hors contexte postopératoire, la littérature ne permet de formuler aucune recommandation sur l'utilisation du BNP — en particulier pour le dépistage d'une dysfonction cardiaque induite par le sepsis ou d'une cause cardiaque à un échec de sevrage ventilatoire, malgré des pistes intéressantes (élévation du BNP associée à un échec d'épreuve de ventilation spontanée dans plusieurs études).

Champ 6 — Quand prescrire un bilan d'hémostase ?

N°	Recommandation	Grade
R6.1	Il faut probablement disposer d'un bilan d'hémostase (TP, TCA, plaquettes) chez tout patient admis en réanimation.	2+
R6.2	Il ne faut probablement pas répéter systématiquement les examens d'hémostase une fois le bilan initial prélevé.	2-
R6.3	Il faut répéter les examens d'hémostase en cas d'anomalies ou de survenue d'une affection aiguë pouvant interférer avec l'hémostase.	1+
R6.4	Il ne faut pas effectuer systématiquement de surveillance biologique de l'activité anticoagulante des traitements utilisés à dose préventive (prophylaxie de la MTEV), en dehors de la surveillance plaquettaire lorsque celle-ci est indiquée.	1-
R6.5	Il faut probablement surveiller l'effet anticoagulant d'un traitement par héparine non fractionnée à doses thérapeutiques par la mesure de l'activité anti-Xa plutôt que par le TCA.	2+

Repère : la corrélation TCA/activité anti-Xa est mauvaise (discordante dans près de la moitié des cas sous HNF). La thrombopénie induite par l'héparine (TIH) complique jusqu'à 5 % des traitements par HNF et 0,1-0,2 % des HBPM. Sous HNF, quelle que soit la dose, surveillance plaquettaire systématique 2×/semaine pendant 21 jours. Sous HBPM, se référer au document HAS : rythme différent selon le contexte (chirurgical/traumatique ou non).

Champ 7 — Examens bactériologiques standards (1/2 : hémocultures)



N°	Recommandation	Grade
R7.1	Il faut prélever des hémocultures devant tout sepsis.	1+
R7.2	Il ne faut probablement pas répéter ces prélèvements de manière systématique.	2-
R7.3	Il faut probablement prélever de nouvelles hémocultures 24h après la première série en cas de suspicion d'endocardite ou de syndrome infectieux persistant avec premières hémocultures restant négatives après 24h d'incubation.	1+
R7.4	Il faut probablement réduire le nombre de paires d'hémocultures à 2-3 par épisode clinique et par tranche de 24h, pour réduire coûts et spoliation sanguine.	2+
R7.5	Il faut prélever par ponction veineuse directe, en une seule fois, un volume minimum de 40 à 60 mL et le répartir dans 4 à 6 flacons (2-3 aérobies, 2-3 anaérobies), pour minimiser faux positifs (défaut d'antisepsie) et faux négatifs (volume insuffisant).	1+

Aucune recommandation possible (source) : sur le prélèvement d'hémocultures systématiques en cas de traitements interférant avec le monitoring de la température (hypothermie thérapeutique, épuration extra-rénale continue).

Repère : 3 paires d'hémocultures détectent 98 % des bactériémies (contre 73 % avec 1 paire, 90 % avec 2) ; c'est le volume prélevé, pas le nombre de ponctions, qui conditionne la sensibilité — 20 mL augmente le taux de positivité de 30 % par rapport à 10 mL (minimum souhaitable chez l'adulte).

Champ 7 (2/2) — Prélèvements pulmonaires, ECBU, coproculture

Prélèvements pulmonaires (pneumonies nosocomiales, patients immunodéprimés exclus) :

N°	Recommandation	Grade
R7.6	Il faut réaliser des prélèvements microbiologiques pulmonaires uniquement en cas de suspicion de pneumonie nosocomiale, en respectant les conditions de prélèvement/acheminement pour une interprétation fiable.	1+
R7.7	Il faut probablement réaliser des prélèvements pulmonaires devant toute suspicion de pneumonie nosocomiale pour identifier le germe et adapter l'antibiothérapie.	2+
R7.8	Il ne faut pas répéter les prélèvements pulmonaires en cas d'évolution favorable d'une pneumonie nosocomiale.	1+
R7.9	Il ne faut probablement pas réaliser de prélèvements pulmonaires de « dépistage » systématiques, y compris chez les patients en SDRA.	2-
R7.10	Il faut probablement dépister la grippe, même en situation nosocomiale, en cas de contexte épidémique ou de notion de contagion, en particulier chez les patients avec comorbidités respiratoires ou cardiovasculaires.	2+

R 7.2.5 (numérotation et absence de grade telles qu'imprimées dans la source — anomalie disclosed, non renumérotée « R7.11 ») : concernant les modes de prélèvement pulmonaire, les experts renvoient à la recommandation Q2 de la recommandation SRLF-SFAR-SPLF « Stratégies de réduction de l'utilisation des antibiotiques à visée curative en réanimation ».

Examen cytotuberculeux des urines (ECBU) :

N°	Recommandation	Grade
R7.12	Il faut réaliser un ECBU à visée diagnostique en présence de signes cliniques d'infection urinaire compliquée (pyélonéphrite aiguë, prostatite) ou en cas de sepsis sans autre porte d'entrée identifiée.	1+
R7.13	Il ne faut pas réaliser d'ECBU de contrôle 48-72h après le début de l'antibiothérapie, sauf en cas de non-réponse clinique au traitement.	1-
R7.14	Il ne faut pas dépister systématiquement les colonisations urinaires (bandelette ou ECBU), en dehors de situations à risque (femmes enceintes, intervention chirurgicale sur les voies urinaires).	1+

Coproculture :

N°	Recommandation	Grade
R7.15	Il faut réaliser une coproculture standard en cas de selles diarrhéiques uniquement si le patient est hospitalisé depuis moins de 3 jours.	1+

Pertinence des examens en réanimation

Méthodologie, 8 champs, 42 recommandations & sources



N°	Recommandation	Grade
R7.16	Il ne faut pas réaliser de coproculture standard de contrôle en cas de première coproculture négative, même si les diarrhées persistent (toutes les diarrhées n'étant pas d'origine infectieuse).	2-
R7.17	Il faut rechercher d'autres bactéries entéropathogènes si la coproculture standard est négative en cas de contexte particulier précisé dès l'entrée : voyage récent en pays tropical, toxi-infection alimentaire collective, syndrome cholériforme ou diarrhée hémorragique.	1+
R7.18	Il ne faut pas réaliser de coproculture standard chez le patient hospitalisé depuis plus de 3 jours, excepté en cas d'immunodépression.	2+
R7.19	Il faut rechercher des micro-organismes particuliers en cas de diarrhée secondaire à un traitement antibiotique (<i>Clostridium difficile</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Clostridium perfringens</i> producteur d'entérotoxine).	1+
R7.20	Il faut rechercher le <i>Clostridium difficile</i> de façon spécifique, sans l'associer à la demande d'une coproculture standard (contexte totalement différent).	1+
R7.21	Il ne faut pas réitérer la recherche de <i>Clostridium difficile</i> lorsqu'elle est positive.	1-

Champ 8 — Prescrire une radiographie thoracique (RT) au lit ?

N°	Recommandation	Grade
R8.1	Il ne faut pas faire de RT au lit quotidienne systématique chez les patients intubés et ventilés.	1-
R8.2	Il faut probablement réaliser une RT en cas d'altération des échanges gazeux, d'augmentation des pressions d'insufflation (pression de plateau) ou de modifications auscultatoires faisant suspecter une anomalie parenchymateuse/pleurale — bien que le scanner (voire l'échographie pulmonaire) soit vraisemblablement supérieur.	2+
R8.3	Il faut probablement faire une RT au décours de la pose de dispositifs invasifs (sonde d'intubation, canule de trachéotomie, cathéter veineux central en territoire cave supérieur, drain thoracique, sonde gastrique) pour en vérifier la position et l'absence de complications.	2+
R8.4	Il faut probablement envisager l'échographie thoracique comme alternative à la RT pour détecter des anomalies pleurales (pneumothorax, pleurésie) voire parenchymateuses (foyer, atélectasie).	2+

Repère : une stratégie de RT « à la demande » (sur critères cliniques ou gazométriques) est efficace et sûre par rapport à la RT quotidienne systématique (pas de différence de durée de ventilation ni de mortalité). La RT systématique à l'admission pour détresse respiratoire n'est pas non plus justifiée (scanner plus performant, échographie cardiaque/pulmonaire rapide et précise) — la RT d'admission doit être réservée aux situations où scanner et échographie ne peuvent être réalisés.

Sources et traçabilité

Document source : « Pertinence de la prescription des examens biologiques et de la radiographie thoracique en réanimation » — RFE commune SFAR-SRLF. Texte validé par le CA de la SFAR (15/12/2016) et de la SRLF (13/12/2016).

Méthodologie : méthode GRADE®, méthode PICO — voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2017/01/2_RFE-EC-en-rea-version-15-12-16.pdf

Couverture : intégralité des 42 items numérotés (R1.1-R8.4, y compris l'anomalie de numérotation « R 7.2.5 ») et des 3 cas explicites « aucune recommandation possible » — voir disclosure de la divergence de comptage source (49 annoncées vs 42 comptées) en page 1.

Avertissement — document validé 2016/2017 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR ou la SRLF. Se référer aux protocoles locaux et au texte intégral (106 références bibliographiques, non reprises ici) pour toute décision clinique.